

ANNALES EVCF 2009-2024 GERIATRIE



Ce que tu trouveras ici

Ce document rassemble toutes les annales officielles disponibles sur le site du CNG et même parfois plus ! Un excellent point de départ pour t'entraîner, repérer les thématiques récurrentes et comprendre la logique du concours.

Mais attention : les sujets seuls ne suffisent pas.



Pour progresser vraiment, il faut des corrections détaillées les et des rappels pédagogiques structurés, basés sur dernières recommandations.



Pour aller plus loin

Si tu veux accéder à la version corrigée complète, avec :

- les explications item par item
- les rappels de cours actualisés
- les références officielles



rends-toi dès maintenant sur www.prepevc.fr

Tu y retrouveras :

- Nos formations EVC complètes (voie interne & externe)
- Des banques de QCM et QROC corrigés par spécialité
- Des suivis personnalisés avec des praticiens hospitaliers



Ne laisse pas ta réussite au hasard

Les lauréats ne sont pas les plus "chanceux".

Ce sont ceux qui ont compris comment s'entraîner intelligemment, avec la bonne méthode et les bons outils.

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2009

Sujet :

Prise en charge d'un AVC chez un patient de plus de 80 ans, dans les 48 premières heures.

Question n°1 :

Bilan clinique initial

Question n°2 :

Examens complémentaires

Question n° 3

Aspects étiologiques : facteurs de risque selon les mécanismes.

Gériatrie

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2011

Sujet : Maladie d'Alzheimer débutante chez un sujet âgé en
consultation

Question 1

Quels sont les critères diagnostiques de la démence de type
Alzheimer selon le DSM IV ?

Question 2

En pratique, qu'allez-vous rechercher à l'interrogatoire du patient
concernant les fonctions cognitives et les éléments organiques autre
que cognitifs ?

Question 3

Pourquoi compléter ce premier entretien avec celui de l'aidant ?

Question 4

Qu'allez-vous rechercher à l'examen physique et pourquoi ?

Question 5

Enumérez sans les décrire les tests de débrouillage effectués lors de l'entretien.

Question 6

Quel bilan complémentaire allez-vous prescrire pour conforter votre diagnostic et qu'en attendez-vous ?

Question 7

Le diagnostic de maladie d'Alzheimer légère est porté, quel traitement médicamenteux spécifique prescrivez-vous ?

Question 8

Quels sont les éléments de surveillance de ce traitement médicamenteux ?

Question 9

Quelles autres mesures peuvent être envisagées concernant les comorbidités et la vie quotidienne de ce patient ?

Question 10

Citez sans les décrire les troubles psycho-comportementaux pouvant survenir au cours d'une maladie d'Alzheimer ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2012

Sujet :

Madame B... âgée de 86 ans est amenée au SAU par les pompiers après une chute à domicile. Elle a été retrouvée au sol depuis plusieurs heures par son aide ménagère.

Question n°1 :

Quelles complications immédiates de la chute recherchez-vous ?

Question n°2 :

Que recherchez-vous comme étiologie les plus fréquentes à cette chute ?

Question n°3 :

Quel bilan para clinique en première intention, et en deuxième intention effectuez-vous ?

Question n°4 :

Quels sont les facteurs prédictifs d'une nouvelle chute ?

Question n°5 :

Quelles sont les différentes composantes du syndrome Post-chute ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2013

Sujet :

Madame X, 89 ans est admise en soins de suite après avoir été opérée d'une fracture du col du fémur.

QUESTION N°1 :

Citez les facteurs de risques d'ostéoporose

QUESTION N°2 :

Vous recevez les résultats de sa numération formule sanguine.

a) Hémoglobine 10,1g/dL, Volume Globulaire Moyen 86fl, Plaquettes 400 000/mm³, leucocytes 10 000/mm³ sans anomalie de formule. Décrivez l'anomalie.

b)Citez les causes possibles.

QUESTION N°3 :

Quels sont les critères cliniques et biologiques pour établir un diagnostic de dénutrition ?

QUESTION N°4 :

Citez les complications de décubitus qu'il faut redouter.

QUESTION N°5 :

a) Quelles sont les mesures de prévention de l'apparition d'escarres ?

b) Classification et description des 4 différents stades de l'escarre.

QUESTION N°6 :

Quelles sont les règles de rédaction d'une ordonnance de morphinique per os ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2014

Sujet :

Madame X âgée de 88 ans est adressée aux urgences par son médecin traitant pour agitation survenant en l'absence de traumatisme. Vous évoquez un syndrome confusionnel.

Question N°1 :

Enoncer les signes neuro-cognitifs du syndrome confusionnel

Question N°2 :

Quelles sont les manifestations psychologiques et/ou comportementales du syndrome confusionnel ?

Question N°3 :

Quelles sont les 3 caractéristiques évolutives du syndrome confusionnel ?

Question N°4 :

Quels sont les 2 signes physiques à rechercher systématiquement à l'examen neurologique pouvant justifier des examens complémentaires ?

Question N°5 :

Enoncer les facteurs favorisants ou prédisposants du syndrome confusionnel.

Question N°6 :

Quelles principales étiologies médicamenteuses recherchez vous face à un

syndrome confusionnel ?

Question N°7 :

Enoncer les autres facteurs précipitants ou étiologiques du syndrome confusionnel.

Question N°8 :

Citer les principales complications du syndrome confusionnel.

Question N°9 :

Citer les examens complémentaires systématiques de première intention dans le cadre d'une enquête étiologique.

Question N°10 :

Enoncer les principes thérapeutiques du syndrome confusionnel

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2015

Sujet:1

Madame X âgée de 92 ans vivant en EHPAD est hospitalisée pour une pneumonie bactérienne aigue

QUESTION N° 1

Quels sont les germes les plus fréquents sur ce terrain ?

QUESTION N° 2

Citez trois signes cliniques vous ayant permis de faire le diagnostic

QUESTION N° 3

Citez 5 signes cliniques de gravité ?

QUESTION N° 4

Quels sont les signes biologiques à visée diagnostique?

QUESTION N° 5

Quel examen bactériologique demandez-vous ?

QUESTION N° 6

Quels sont les antibiotiques (avec les doses) recommandés dans ce cas en dehors de signes de gravité ?

QUESTION N° 7

Quelles autres mesures médicamenteuses pouvez-vous prescrire ?

QUESTION N° 8

Quelles mesures non médicamenteuses ?

QUESTION N° 9

Citez 5 facteurs pronostiques liés au terrain de la pneumonie d'un sujet âgé?

QUESTION N° 10

Quelles sont les mesures préventives des pneumonies en institution ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2016

Sujet :

Madame X âgée de 87 ans est hospitalisée pour orthopnée, œdèmes des membres inférieurs et turgescence jugulaire, avec un diagnostic de décompensation d'insuffisance cardiaque.

Question n°1

Citez d'autres signes cliniques non spécifiques d'insuffisance cardiaque chez la personne âgée.

Question n°2

Citez les autres pathologies qui peuvent mimer une insuffisance cardiaque (diagnostics différentiels)

Question n°3

Citez les principaux facteurs précipitant une poussée d'insuffisance cardiaque

Question n°4

Quels examens complémentaires demandez-vous chez cette patiente ? Justifiez brièvement.

Question n°5

Quelle prise en charge mettez-vous en œuvre pour le traitement de la phase aiguë de l'insuffisance cardiaque ?

Question n°6

Après stabilisation de la patiente, quelles mesures thérapeutiques et de surveillance au long cours mettez-vous en œuvre ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales
2017

TOUS LES SUJETS SONT A TRAITER

Sujet:n° 1

Question N° 1

Citez les symptômes de l'insuffisance cardiaque.

Question N° 2

Citez les signes cliniques d'insuffisance cardiaque.

Question N° 3

Citez les principales étiologiques.

Question N° 4

Citez les principaux facteurs déclenchants.

Question N° 5

Citez les examens para cliniques devant une poussée d'insuffisance cardiaque.

Question N° 6

Traitement de l'insuffisance cardiaque aigue.

Question N° 7

L'échographe indique une fraction d'éjection à 35%. Donnez les modalités de traitement du patient.

Question N° 8

Au domicile,
Quelles sont vos prescriptions de suivi clinique et paraclinique?

Question N° 9

Mesures préventives de l'insuffisance cardiaque.

Sujet N° 2

Monsieur M se présente en consultation mémoire pour une plainte mnésique.
On découvre un syndrome parkinsonien.

Question N° 1 :

Donnez la définition des troubles neurocognitifs majeurs selon le DSM5

Question N° 2 :

Identifiez les 3 signes cardinaux du syndrome extrapyramidal

Question N° 3 :

Que recherche-t-on à l'examen clinique du syndrome extra-pyramidal ?

Question N° 4 :

Chez un patient qui présente des troubles cognitifs et un syndrome parkinsonien, quels diagnostics doit-on évoquer ?

Question N° 5 :

Décrivez les caractéristiques de la Paralyse Supranucléaire Progressive

Question N° 6 :

Décrivez les critères diagnostiques actualisés de la Démence à Corps de Lewy

Question N° 7 :

Le diagnostic de Démence à Corps de Lewy est finalement retenu. Quelle est votre proposition de prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2018

TOUS LES SUJETS SONT A TRAITER

Sujet :1

Une femme de 86 ans est adressée au SAU pour asthénie profonde. Le ionogramme sanguin retrouve une natrémie à 116 mmol/l, une kaliémie à 5 mmol/l, une urée à 13 mmol/l et une créatininémie à 100 µmol/l.

Question N° 1 :

Quel(s) trouble(s) hydroélectrolytique(s) repérez-vous ?

Question N° 2 :

Quelle urgence médicale endocrinienne faut-il rechercher d'emblée ?
interpréter cette (ces) anomalie(s) (maximum 4 examens) ?

Question N° 3 :
Sur l'ordonnance, on retrouve : diazépam, citalopram, irbesartan,
hydrochlorothiazide, colchicine, oméprazole.

Quel bilan minimal biologique supplémentaire demandez-vous pour

Question N° 4 :

Quel(s) médicament(s) de cette ordonnance peuvent expliquer une dysnatrémie ?

Question N° 5 :

Quel(s) médicament(s) de cette ordonnance peuvent expliquer une hypokaliémie ?

Question N° 6 :

Quel(s) médicament(s) de cette ordonnance peuvent expliquer une hyperkaliémie ?

Le prélèvement était hémolysé. Le contrôle du ionogramme sans garrot retrouve une natrémie identique mais une kaliémie à 4 mmol/l. La radiographie thoracique montre un foyer systématisé de la base droite.

Question N° 7 :

Quel mécanisme évoquez-vous pour expliquer la dysnatrémie ?

Question N° 8 :

L'hypothèse évoquée à la question 7 est confirmée. Dans ce cas, quelle(s) mesure(s) préconisez-vous pour normaliser la natrémie ?

SUJET 2

Un patient de 92 ans présente une altération de l'état général récente. Dans le bilan de débrouillage demandé par son médecin traitant, on observe : 10 000 leucocytes/mm³ dont 8200 polynucléaires neutrophiles/mm³, hémoglobine 7,8 g/dl, VGM 73 μ³, plaquettes 525 000/mm³.

Question N° 1 :

Quelles sont les anomalies de l'hémogramme ?

Question N° 2 :

Quelle carence suspectez-vous ?

Question N° 3 :

www.prepevc.fr

Quel examen biologique demandez-vous pour confirmer cette carence (une seule réponse)?

Cette carence est confirmée.

Question N° 4 :

Quelle(s) anomalie(s) de la numération formule sanguine peu(ven)t être expliquée(s) par cette carence ?

Le bilan biologique retrouve par ailleurs une C-reactive protein (CRP) à 90 mg/l (N<5 mg/l).

Question N° 5 :

~~Quelle(s)~~ anomalie(s) de la numération formule sanguine peu(ven)t être expliquée(s) par ce résultat ?

Question N° 6 :

Quelle principale hypothèse diagnostique permettrait d'expliquer la carence observée et l'élévation de la CRP chez ce patient ?

SUJET 3

Une patiente de 78 ans est admise pour un état d'agitation. Sa famille nous signale que la patiente vit seule et qu'elle était parfaitement autonome pour toutes les activités de la vie courante jusqu'à la semaine précédente.

L'interrogatoire retrouve une désorientation temporelle et spatiale chez une patiente visiblement anxieuse avec des propos incohérents. L'examen neurologique est normal par ailleurs. Le traitement habituel de la patiente comprend amlodipine, aspirine, pravastatine, tramadol, fluoxétine.

Question N° 1 :

Comment qualifiez-vous ce tableau neurologique ?

Question N° 2 :

Parmi les médicaments de la patiente, le(s)quel(s) est (sont)

susceptible(s) d'entraîner ce tableau neurologique ?

Question N° 3 :

Quel examen d'imagerie demandez-vous en première intention dans le contexte de l'urgence ?

Question N° 4 :

Quels troubles métaboliques pourraient expliquer ce tableau (citez-en au maximum 4) ?

La patiente est plus calme. L'examen physique retrouve une matité suprapubienne. Le bladder-scan met en évidence un globe urinaire à 600 cc. Vous préconisez un sondage.

Question N° 5 :

Parmi les médicaments de la patiente, lequel est le plus susceptible d'entraîner une rétention aiguë d'urines ?

Question N° 6 :

Quelles sont les 2 principales hypothèses non médicamenteuses susceptibles d'entraîner une rétention aiguë d'urines chez cette patiente ?

L'épisode neurologique aigu a été résolutif.

Question N° 7 :

Prévoyez-vous de revoir la patiente à distance ? si oui dans quel but ?

SUJET 4

Une patiente de 86 ans est admise pour œdème pulmonaire aigu. Le seul facteur de décompensation cardiaque retrouvé est une arythmie complète par fibrillation atriale rapide. Elle n'a pas d'antécédent particulier et ne prend aucun traitement.

Question N° 1 :

Citez les items utilisés pour le calcul du score de CHA2DS2-VASc.

Question N° 2 :

~~Quel est le~~ score de CHA2DS2-VASc chez cette patiente ?

Question N° 3 :

Y a-t-il une indication à une anticoagulation efficace chez cette patiente ?
pourquoi?

Vous envisagez de mettre la patiente sous apixaban (anticoagulant oral direct).

Question N° 4 :

Quel paramètre biologique devez-vous vérifier avant de mettre en route cette prescription ?

Quinze jours après le retour à domicile, la patiente chute de sa hauteur et perd rapidement connaissance. Le scanner cérébral sans injection objective un hématome sous-dural compressif avec effet de masse. Alors que vous vous apprêtez à la confier au neurochirurgien, son mari s'oppose à tout « acharnement thérapeutique ». Il vous montre une lettre manuscrite datée et signée par son épouse indiquant ses dernières volontés relatives aux soins médicaux.

Question N° 5 :

Comment s'appelle la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie ?

Question N° 6 :

~~Dans le cadre~~ de cette loi, à quoi correspond la lettre de la patiente ?

Question N° 7 :

Dans le cadre de cette loi, quel rôle la patiente a-t-elle attribué à son mari ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales 2019

L'ENSEMBLE DES SUJETS EST A TRAITER

Sujet:1

Madame X, 82 ans, est hospitalisée en gériatrie aigue au décours d'une chute avec station au sol de durée indéterminée. Dans le dossier, vous constatez qu'elle a chuté 4 fois au cours des 6 derniers mois.

Question N° 1 :

Comment se définissent les chutes à répétition ?

Question N° 2 :

Quelles complications recherchez-vous dans le cadre d'un maintien prolongé au sol ?

Question N° 3 :

Quels symptômes caractérisent un syndrome post-chute ?

Question N° 4 :

Citez trois grandes classes thérapeutiques principales qui favorisent les chutes. Pour chacune, illustrez par un exemple de sous classe.

Question N° 5 :

Quelle est la définition d'une hypotension orthostatique lors de la réalisation d'un test de recherche ?

Question N° 6 :

Citez les examens paracliniques à demander lors d'un bilan de chutes répétées, selon la situation.

Question N° 7 :

Citez les examens paracliniques qu'il n'est pas utile de réaliser à titre systématique lors d'un bilan de chutes répétées.

Question N° 8 :

Citez 2 tests cliniques spécifiques d'évaluation de l'équilibre et de la marche que vous pouvez réaliser dans le cadre d'une consultation de bilan de chutes.

Question N° 9 :

Citez les principaux axes de prise en charge de toute personne faisant des chutes répétées.

Sujet 2

Un homme de 90 ans est adressé au Service admission et urgences pour altération de l'état général, perte d'appétit et somnolence depuis quelques jours. Il vit seul refusant toute aide à domicile.

A l'examen clinique on observe un pli cutané sous claviculaire, une sécheresse de la muqueuse buccale avec une langue rouge et douloureuse, un abdomen tendu et météorisé, une hyperthermie à 38,2°C et une fréquence cardiaque à 91 bpm, une pression artérielle à 90 / 72 mm Hg.

Le premier bilan sanguin constate une natrémie à 160 mmol/l, une kaliémie à 3,2 mmol/l, une urémie à 12 mmol/l et une créatinémie à 180 µmol/l.

Question N° 1 :

Quel diagnostic clinico-biologique portez-vous ?

Question N° 2 :

Quels sont les deux mécanismes physiopathologiques qui expliquent le tableau clinico-biologique ?

L'histoire récente du patient révèle une antibiothérapie pour pneumopathie 15 jours avant l'admission.

Question N° 3 :

Quelles sont les deux complications de l'antibiothérapie que vous recherchez expliquant le tableau clinico-biologique ?

Après une semaine d'hospitalisation, apparaît une escarre du talon droit et sacrum

Question N° 4 :

Quels sont les quatre mécanismes locaux favorisant la survenue d'une escarre ?

Question N° 5 :

Citez le nom d'une échelle d'évaluation du risque d'escarre.

Question N° 6 :

Citez 3 grandes mesures préventives de survenue d'une escarre.

Question N° 7 :

Le patient pèse habituellement 62 kg pour 1m74 (IMC : 20,5) , il a perdu 6 % du poids en 6 mois, son albuminémie est à 32 g/ l alors que la CRP s'est normalisée.

Donner la formule de calcul de l'index de masse corporelle (IMC)

Question N° 8 :

Comment qualifiez-vous l'état nutritionnel de ce patient ?

—GERIATRIE

EPREUVE DE CONNAISSANCES FONDAMENTALES

TOUS LES SUJETS SONT A TRAITER

CAS CLINIQUE 1

Une femme âgée de 80 ans est admise en service de gériatrie pour impotence fonctionnelle rendant difficile son retour au domicile. Elle est adressée par le service-porte des urgences hospitalières où elle a été admise pour une fracture du poignet droit de type Pouteau-Colles survenue à la suite d'une chute. Cette chute s'est produite un jour de grand froid et elle a glissé sur le trottoir glacé. Vous apprenez qu'elle vit seule de manière indépendante à domicile. Elle ne déclare aucun proche à prévenir. Elle a pour antécédents une hypertension artérielle essentielle traitée par lisinopril (20 mg/j) (un inhibiteur de l'enzyme de conversion), et une maladie de Horton traitée depuis un an par prednisone. La dose initiale était de 40 mg/j, et elle est actuellement de 7,5 mg/j. Elle prend par ailleurs un somnifère chaque soir, le zolpidone 7,5 mg (1 cp/j). A l'examen, la température est normale, la pression artérielle à 130/72 mmHg, sans hypotension orthostatique, le poids est à 37 kg pour une taille à 150 cm, alors que la taille indiquée sur ses papiers d'identité est de 1,58 m. La fracture a été réduite et ostéosynthésée par broche au bloc d'urgence. Le prélèvement sanguin montre : glycémie 5,2 mmol/l, Na⁺ 139 mmol/l, K⁺ 4,2 mmol/l, créatinine 65 µmol/l, calcium 2,4 mmol/l, CRP < 5 mg/l, transaminases dans les normes ainsi que les gamma GT, phosphatases alcalines à la limite supérieure de la normale, NFS : globules blancs 7000/mm³ dont 55 % de polynucléaires neutrophiles, Hb 11 g/dl, VGM 103 µ³, plaquettes 200000/mm³.

Question 1 : Quelle pathologie osseuse évoquez-vous devant ce tableau clinique ? Citez chaque élément du diagnostic clinique ? **Question 2 :** Quels sont chez cette patiente les facteurs de risque de cette maladie osseuse que vous notez à partir de l'observation ? Citez les autres facteurs de risque à rechercher. **Question 3 :** Quels les examens complémentaires réalisez-vous dans un premier temps pour explorer cette ostéopathie (justifier vos réponses) ? Quel(s) traitement(s) proposez-vous dans un premier temps ? Vous avez organisé une sortie à son domicile avec des aides appropriées (auxiliaire de vie et portage de repas à domicile) et un contact a été pris avec la voisine qui viendra lui rendre visite et vérifiera que tout se passe bien. Elle quitte l'hôpital avec une ordonnance, un courrier pour le médecin traitant et un rendez-vous en orthopédie pour son suivi.

Vous la revoyez en consultation 3 mois plus tard. Le traitement de sortie n'a pas été modifié et a été bien suivi. La consolidation de sa fracture est obtenue. Le bilan biologique que vous avez prescrit est normal et ne montre pas de carence vitaminique. L'état fonctionnel du membre supérieur est satisfaisant et la patiente a retrouvé toute son indépendance pour les actes de la vie quotidienne. La pression artérielle est 140/85 mmHg.

Question 4 : Faut-il faire d'autres investigations ?

Question 5 : Quelles prise en charge non médicamenteuse allez-vous entreprendre ?

Question 4 : Faut-il entreprendre d'autres traitements pour de pathologie osseuse ? Justifiez vos réponses.

CAS CLINIQUE 2

Une femme de 81 ans consulte pour des douleurs de la région trochantérienne droite apparues il y a 2 ans sans qu'une circonstance déclenchante ne soit retrouvée. Lors d'une précédente consultation aux urgences, une radiographie avait été réalisée. Le diagnostic de coxarthrose droite avait été annoncé à la malade et une ordonnance de paracétamol 500 mg (antalgique) à la demande a été réalisée.

Question 1 : Quelles sont les caractéristiques des douleurs provoquées par une coxarthrose ?

Question 2 : Quels signes recherchez-vous à l'examen physique de cette personne compatibles avec le diagnostic de coxarthrose ?

Question 3 : Comment évaluez-vous l'intensité de la douleur ?

Question 4 : Quelles conséquences médico-sociales de cette coxarthrose, autres que la douleur, recherchez-vous ?

Question 5 : Quelles anomalies sur une radiographie de hanche sont en faveur du diagnostic d'une coxarthrose ?

Question 6 : Citez 2 causes de douleurs de hanche autres que la coxarthrose, et indiquez leurs principales caractéristiques qui les différencient de la coxarthrose ?

Question 7 : Quelles mesures thérapeutiques non médicamenteuses instituez-vous pour cette patiente ?

Question 8 : Quelles mesures thérapeutiques médicamenteuses instituez-vous dans un premier temps pour cette patiente ? **Question 9 :** Après avoir suivi vos conseils et les traitements prescrits pendant dix mois, la patiente garde des douleurs importantes et présente une gêne importante à la marche. Quelles thérapeutiques proposez-vous (justifiez vos réponses) ?

GERIATRIE

Épreuve de Vérification des Connaissances Fondamentales

Question N°1 :

Quelle est la définition de l'hypotension orthostatique ?

Question N°2 :

Citez 5 symptômes d'épisode dépressif caractérisé chez la personne âgée.

Question N°3 :

Citez cinq critères du DSM V définissant le syndrome confusionnel.

Question N°4 :

Quel bilan paraclinique prescrivez-vous chez une personne âgée diabétique qui fait des chutes à répétition ?

Question N°5 :

Citez 8 facteurs dits « prédisposants » des chutes à répétition chez une personne âgée.

Question N°6 :

Quelle classe médicamenteuse prescrivez-vous en première ligne devant un épisode dépressif caractérisé de la personne âgée ?

Question N°7 :

Quels scores permettent d'évaluer le risque d'événements hémorragiques et ischémiques chez un sujet âgé en fibrillation atriale ?

Question N°8 :

Citez trois critères majeurs qui vous orienteraient vers le diagnostic de maladie à corps de Lewy chez un patient qui présente un trouble neurocognitif majeur.

Question N°9 :

Citer 4 tests permettant d'évaluer le risque de chute chez la personne âgée.

Question N°10 :

Quelles sont les indications à une prescription de scanner cérébral chez une personne âgée confuse ?



Question N°11 :

Citez 5 classes d'antihypertenseurs recommandées chez la personne âgée.

Question N°12 :

Citez trois critères diagnostiques de la dénutrition chez la personne âgée (soit selon la définition HAS 2007 soit selon la définition HAS 2021).

Question N°13 :

Quel est l'échelle de référence pour évaluer les symptômes psycho-comportementaux chez une personne âgée ayant un trouble neurocognitif majeur. Citer 5 critères de cette échelle.

Question N°14 :

Quelles sont les 5 classes thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ?

Question N°15 :

Quels sont les quatre stades des escarres ?

Question N°16 :

Citez 6 facteurs de risque (intrinsèques) d'escarres.

Question N°17 :

Quel bilan biologique de première intention prescrivez-vous devant une confusion chez une personne âgée ?

Question N°18 :

Citer 4 classes du traitement de fond de l'insuffisance coronarienne.

Question N°19 :

Citer 3 échelles d'évaluation de la douleur chez la personne âgée.

Question N°20 :

Citer 3 caractéristiques d'une douleur neuropathique.

Question N°21 :

Citer la classe de médicaments à éviter de prescrire dans la maladie à corps de Lewy.

Question N°22 :

Citer 3 critères de fragilité selon Fried.

Question 23 :

Citer deux éléments de surveillance biologique du suivi d'un traitement par anticoagulant oral direct.

GERIATRIE

EPREUVE DE VERIFICATION DES CONNAISSANCES FONDAMENTALES 2023

QUESTION 1 :

Donnez 3 caractéristiques du vieillissement cardio – vasculaire et donnez en regard les possibles conséquences cliniques chez un sujet âgé

QUESTION 2:

Donnez 4 critères de fragilité décrits par Fried

QUESTION 3:

Citez 5 des principales causes de dépendance iatrogène

QUESTION 4 :

Quelles sont les 4 activités de l'échelle d'autonomie IADL à évaluer prioritairement dans un bilan de troubles neuro-cognitifs car précocement altérées ?

QUESTION 5 :

Citez 2 critères d'attribution de l'APA

QUESTION 6 :

Citez 5 types de services ou aides techniques que vous pouvez intégrer dans le plan personnalisé d'une personne âgée dépendante, et dites pour chacun si son financement repose principalement sur l'Assurance Maladie ou sur l'APA.

QUESTION 7 :

Donnez 3 caractéristiques de la sauvegarde de justice

QUESTION 8 : Citez 4 sites fracturaires considérés comme signant une fracture sévère en cas d'ostéoporose (selon les recommandations du GRIO- Groupe de Recherche et d'information sur les Ostéoporoses)

QUESTION 9:

Pour la mesure de la densité minérale osseuse chez une femme âgée de 80 ans, quels sont les sites de mesure possibles ? Placez-les par ordre de pertinence

QUESTION 10:

Citez 6 effets secondaires potentiels que vous devez évaluer dès les premiers jours d'initiation d'un traitement morphinique chez un patient âgé

QUESTION 11 :

Selon les critères diagnostiques du DSM5, quels sont les deux éléments permettant de différencier un trouble neurocognitif léger d'un trouble neurocognitif majeur ?

QUESTION 12 :

Citez deux des trois principaux stigmates histologiques caractéristiques d'une maladie d'Alzheimer sur un examen neuropathologique de cerveau.

QUESTION 13 :

Dans le cas de troubles neurocognitifs avérés et portant surtout sur l'attention et les fonctions exécutives et visio-spatiales, quels sont les 4 signes cliniques cardinaux du diagnostic d'une maladie à corps de Lewy selon les critères de McKeith de 2017 ?

QUESTION 14 :

Quand une ponction lombaire est réalisée dans le bilan d'une maladie d'Alzheimer, quels sont les biomarqueurs dosés dans le liquide cérébro-spinal et quel est leur profil typique ?

QUESTION 15 :

Citez 5 éléments de la définition d'un syndrome confusionnel selon le DSM5

QUESTION 16 :

Citez 2 diagnostics différentiels de syndrome confusionnel

QUESTION 17 : Devant un syndrome confusionnel d'un patient âgé, quel bilan biologique de 1^{ère} intention prescrivez-vous ? Expliquez pour chaque examen ce que vous recherchez

QUESTION 18 :

Citez 2 situations dans lesquelles le scanner cérébral devient un examen de 1^{ère} intention en cas de syndrome confusionnel

QUESTION 19 :

Citez 2 tests, réalisables en consultation ou dans la chambre d'un patient âgé, qui permettent de détecter une vulnérabilité quant au risque de chute. Et décrivez brièvement chacun.

QUESTION 20 :

Chez un patient hospitalisé pour chute avec station prolongée au sol, citez 5 complications du maintien au sol.

QUESTION 21 :

Chez un patient âgé hospitalisé pour chute, citez 6 types de médicaments que vous allez rechercher en priorité sur l'ordonnance du patient, afin de détecter un facteur iatrogène prédisposant ou précipitant (ne pas donner de nom de médicament mais des familles de médicaments)

QUESTION 22

Hypotension orthostatique : décrire comment vous la recherchez et ce que vous retenir comme critères diagnostiques

QUESTION 23 :

Donnez 3 symptômes clés du syndrome post chute.

QUESTION 24 :

Sans évoquer l'alitement prolongé ni les facteurs précipitants, donnez 5 situations pathologiques ou maladies chroniques considérées comme facteurs de risque d'escarre.

QUESTION 25 :

Un patient alité depuis quelques jours présente une phlyctène au niveau d'un point de pression sur un talon. Est-ce que cela peut être une escarre ? Si oui à quel stade l'évaluez-vous ? Si non à quoi correspond la phlyctène ?

QUESTION 26 :

Citez 4 des grandes lignes des mesures de prévention des escarres chez un patient âgé immobilisé (par exemple après un AVC).

QUESTION 27 :

Chez un patient âgé dénutri, quels sont les critères de dénutrition sévère ?

QUESTION 28 :

Pour un patient âgé dénutri, quels sont les apports quotidiens recommandés en calories et en protéines ?

QUESTION 29 :

En fonction du lieu de vie (domicile ou EHPAD) ou du type de structure hospitalière (court séjour, SSR ou USLD), quelles sont les recommandations de fréquence de surveillance du poids pour dépister une dénutrition chez le sujet âgé ?

QUESTION 30 :

Indication d'une transfusion de culot(s) globulaire(s) chez le sujet âgé : que retenir comme seuils et objectifs transfusionnels en fonction des comorbidités d'un patient âgé anémique ?

QUESTION 31 :

Quelles sont les deux grandes lignes de la prise en charge d'une hyponatrémie par SIADH ?

QUESTION 32 :

Quelles sont les 3 grandes causes d'une hyponatrémie avec augmentation du secteur extracellulaire ?

QUESTION 33 :

En cas d'hyponatrémie de dilution à l'occasion d'une décompensation d'une insuffisance cardiaque, quel est l'état d'hydratation des secteurs intracellulaire et extracellulaire ?

QUESTION 34 :

En face de chaque symptôme énoncé, dites s'il s'agit d'un symptôme classique de déshydratation intra (DIC) – ou extra – cellulaire (DEC) :

Perte de poids - DIC DEC

Baisse de la PA - DIC DEC

Sécheresse des muqueuses - DIC DEC

Accélération de la FC - DIC DEC

Somnolence - DIC DEC

QUESTION 35 :

Citez les 3 causes principales d'anémie macrocytaire du sujet âgé avec un VGM > 105 μm^3 .

Gériatrie EVCF 2024

QUESTION 1

Donnez cinq exemples de syndromes gériatriques.

QUESTION 2

La recherche du consentement est parfois difficile lorsqu'un patient, atteint d'altération cognitive sévère, est dans l'incapacité de comprendre ou d'exprimer son positionnement.

La loi prévoit des alternatives à la recherche directe du consentement auprès du patient.

Citez trois éléments à rechercher afin d'explorer ce positionnement.

QUESTION 3

Répondez par oui ou non : En fin de vie, chez les personnes âgées, la pathologie cancéreuse n'est pas prédominante comme chez le sujet jeune. Les pratiques palliatives concernent aussi les maladies telles que les maladies neurodégénératives.

QUESTION 4

Répondez par oui ou non : Dans certaines conditions, la question se pose d'introduire ou de maintenir une nutrition ou une hydratation artificielle chez un patient âgé présentant des troubles de la déglutition.

Si ce patient est dans l'incapacité de comprendre ou d'exprimer son consentement, c'est la famille qui décide.

QUESTION 5

Donnez le nom de deux échelles d'évaluation de la douleur validées pour les personnes âgées présentant des troubles de la communication verbale.

QUESTION 6

Citez les principes pour le relai d'un dispositif délivrant du fentanyl transdermique vers un pousse-seringue de chlorhydrate de morphine IV (calcul de dose et mise en œuvre de traitement).

QUESTION 7

Citez 5 effets indésirables de l'Amitriptyline, commercialisée notamment sous le nom de Laroxyl.

QUESTION 8

Citez la propriété pharmacologique responsable des effets indésirables de l'amitriptyline.

QUESTION 9

Définirladépendance iatrogène liée à l'hospitalisation.

QUESTION 10

Citezles6 principales causes de dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation des personnes âgées.

QUESTION 11

Citez5complications de la contention physique passive.

QUESTION 12

Donnezladéfinition du trouble neurocognitif majeur.

QUESTION 13

Citez2facteursde risque non modifiables de développer la maladie d'Alzheimer et apparentées.

QUESTION 14

Citez5facteursde risque modifiables de développer un trouble neurocognitif majeur.

QUESTION 15

Quelleestladéfinition d'un trouble neurocognitif léger ou trouble cognitif léger (MCI, Mild CognitiveImpairment) ?

QUESTION 16

Quelssontlesprincipaux biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer du liquide cérébro-spinal?Précisez pour chacun s'il est augmenté ou diminué dans cette maladie.

QUESTION 17

Quelssontles4critères centraux / cardinaux de la maladie à corps de Lewy ?

QUESTION 18

Citezl'échelletedépistage de la confusion et ses 4 critères cliniques.

QUESTION 19

Donnez3critèresphénotypiques du diagnostic de dénutrition.

QUESTION 20

Donnezlesdeuxcritères définissant la sarcopénie.

QUESTION 21

Citezles5éléments de surveillance de l'état nutritionnel.

QUESTION 22

Définissez l'escarre stade III.

QUESTION 23

Quels sont les critères diagnostiques d'une hypotension orthostatique ?